

疾病诊断

导致咳嗽的疾病以呼吸系统疾病较多，以下列举常见的呼吸系统疾病。

1.普通感冒

当出现咳嗽、流鼻涕、打喷嚏、鼻塞、嗓子痒、嗓子疼、发热等不适症状时，需考虑普通感冒的可能，一般以上呼吸道症状为主，全身症状少见，通过症状特点即可进行诊断，无需进行病毒培养、血清学检查和影像学检查。

2.流行性感

患者除了有咳嗽症状外，还有发热、肌肉酸痛等常见的症状。

3.急性气管-支气管炎

如果咳嗽逐渐加剧，伴有或不伴有咳痰，持续 2~3 周才逐渐好转，需考虑急性气管-支气管炎的原因，通过体格检查及胸部 X 线检查等即可确诊，本病 X 线检查常无异常或仅有肺纹理增加，体格检查双肺呼吸音粗，有时可听到湿性或干性啰音。

4.感染后咳嗽（PIC）

如果感冒症状消失以后，咳嗽仍然迁延不愈，多表现为刺激性干咳或咳少量白色粘痰，咳嗽持续时间 3~8 周时需考虑感染后咳嗽的可能，通过询问病史、体格检查及胸部 X 线检查等即可确诊。

5.咳嗽变异性哮喘（CVA）

是哮喘的特殊类型，咳嗽是唯一或主要的临床表现，其特点为慢性咳嗽，常伴有明显的夜间刺激性咳嗽，多有接触冷空气、花粉、粉尘等诱因，可能同时伴有过敏性结膜炎、湿疹等其他过敏性疾病，通过支气管激发试验等检查可诊断。

6.嗜酸性粒细胞支气管炎（EB）

如果为慢性刺激性干咳，或伴有少量粘痰，合并有变应性鼻炎，且通过检查发现嗜酸性粒细胞增高，需考虑本病，因职业需要接触面粉、异氰酸或氯氨等情况也可能与本病相关。

7.上气道咳嗽综合征（UACS）/鼻后滴流综合征（PNDS）

如果患者存在发作性或持续性咳嗽，以白天为主，入睡后咳嗽较少，有鼻部或咽喉部症状或疾病史，需考虑本病，综合病史、症状及相关检查即可确诊。

8.变异性咳嗽（AC）

如果患者有过敏物质接触史，症状为慢性咳嗽，多为刺激性干咳，同时经检查痰液中的嗜酸性粒细胞正常、且无气道高反应性，需考虑本病，可通过变应原皮试等检查确诊。

9.慢性支气管炎

如果咳嗽、咳痰持续 2 年以上，每年累积或持续咳嗽至少 3 个月需考虑本病，慢性支气管炎的咳嗽特点是早晨明显，可有白色泡沫痰或黏液痰，加重时也可有夜间咳嗽。

10.支气管扩张症

典型症状为慢性咳嗽、可伴有大量脓痰及间断性咯血，常合并慢性鼻窦炎，可通过 X 线胸片进行辅助诊断。

11.气管-支气管结核

多数合并肺结核，其主要症状为慢性咳嗽，可伴有低热、盗汗、消瘦等结核中毒症状，可通过痰涂片检查等进一步诊断。

12.支气管肺癌

如果有长期吸烟史，出现刺激性干咳、痰中带血、胸痛及消瘦等症状或原有的咳嗽性质发生了改变，需考虑中心型肺癌的可能，可通过影像学检查和支气管镜检查进一步确诊。

心血管疾病：咳嗽并不是特征表现，如肺栓塞，主要表现为突然发生的呼吸困难、胸痛、咯血；左心衰竭，多有既往心脏疾病病史，可有喘憋、不能平卧、咳粉红色泡沫痰等症状，可通过实验室检查、影像学检查辅助诊断。

中枢神经系统疾病：脑炎、脑膜炎等疾病可影响咳嗽中枢导致咳嗽，如未发现其他导致咳嗽的证据，同时又诊断了神经系统疾病，需考虑这种可能。

消化系统疾病：胃食管反流引起的咳嗽为慢性干咳或伴有少量白色粘痰，以白天咳嗽为主，吃酸性食物或油腻食物时容易诱发或加重咳嗽，还可有反酸、胸骨后烧灼感、嗝气等症状，可通过 24 小时食管 PH 值监测等辅助诊断。

心理性咳嗽：多见于儿童，典型症状为日间咳嗽，专注于某一事物或夜间休息时咳嗽消失，常伴随焦虑的症状，和情绪、学习及习惯等有关。

就诊科室

若您出现咳嗽时，需优先考虑前往呼吸内科就诊，因为咳嗽是呼吸内科的常见症状。但引起咳嗽的原因很多，也有例外，具体前往哪个科就诊，需要看其他伴随症状。如果：

咳嗽伴有胸闷、胸痛，建议去心内科就诊；

持续干咳，伴有反酸时，建议去消化内科就诊；

儿童患者，可以前往儿科就诊。